

TEMA 10.9 • REUMATOLOGÍA

Artritis Reumatoide: Tratamiento

PERFIL EUNACOM 1.10.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El tratamiento de la **Artritis Reumatoide (AR)** ha evolucionado drásticamente en las últimas décadas. El objetivo actual es la remisión clínica o la baja actividad de la enfermedad para evitar el daño articular irreversible y mejorar la calidad de vida y sobrevida del paciente. El manejo se basa fundamentalmente en el uso de fármacos que no solo tratan el dolor, sino que alteran el curso de la patología.

Fármacos Modificadores de la Enfermedad (FARME)

Los **FARME** (o *DMARDs*, por sus siglas en inglés *Disease-Modifying Antirheumatic Drugs*) son la piedra angular del tratamiento. A diferencia de los analgésicos comunes, estos medicamentos tienen la capacidad de frenar la progresión de la destrucción ósea y cartilaginosa.

El Metotrexato (MTX)

Es el fármaco de **primera elección** y el estándar de oro en el tratamiento inicial de la AR.

- **Administración:** Se indica en una **dosis única semanal** (vía oral o subcutánea).
- **Beneficios:** Modifica radicalmente la evolución, reduce la intensidad de los síntomas, evita el daño articular y mejora la sobrevida.
- **Suplementación:** Siempre debe acompañarse de **ácido fólico** para reducir efectos secundarios (como la estomatitis o toxicidad hepática).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

El **Metotrexato** es siempre la respuesta correcta como fármaco de primera línea en EUNACOM, a menos que exista una **contraindicación clara** como el embarazo o enfermedad hepática grave.

Otros FARME Sintéticos

Cuando el metotrexato no es suficiente o está contraindicado, se utilizan otros agentes:

TABLA 10.9.1: FÁRMACO VS CARACTERÍSTICAS CLAVE

FÁRMACO	CARACTERÍSTICAS CLAVE
Hidroxicloroquina	El más antiguo y seguro; se usa mucho en formas leves o en combinación. Requiere control oftalmológico.
Leflunomida	Alternativa potente al metotrexato con eficacia similar.
Sulfasalazina	Útil en terapia combinada y frecuentemente usada en embarazadas (bajo supervisión).
Azatioprina / Micofenolato	Inmunomoduladores usados también en otras enfermedades autoinmunes.

Algoritmo de Escalamiento Terapéutico

El tratamiento de la AR es escalonado y depende de la respuesta clínica del paciente (medida habitualmente por índices como el DAS28):

- **Primera Línea:** Monoterapia con **Metotrexato**.
- **Segunda Línea:** Si no hay respuesta adecuada, se puede cambiar a otro FARME o agregar un segundo fármaco (Terapia Doble).
- **Tercera Línea:** Terapia combinada de dos o tres fármacos (Terapia Triple, ej: Metotrexato + Sulfasalazina + Hidroxicloroquina).
- **Última Línea:** Si falla la terapia convencional, se accede a la **Terapia Biológica**.

Terapia Biológica

Se reserva para pacientes que no han respondido a dosis óptimas de FARME sintéticos. En Chile, estos fármacos están cubiertos por la **Ley Ricarte Soto** debido a su alto costo.

- Los más utilizados son los **Anti-TNF alfa** (Anticuerpos monoclonales que bloquean el factor de necrosis tumoral):
- **Etanercept**
- **Adalimumab**
- **Infliximab**

NOTA CLÍNICA

La fisiopatología de la AR implica una cascada inflamatoria donde el **TNF-alpha** juega un rol central en la destrucción del cartílago y la activación de osteoclastos. Los biológicos interrumpen esta señalización de forma específica.

Tratamiento Sintomático y Aduvante

Mientras los FARME comienzan a hacer efecto (lo cual puede tardar semanas), es necesario manejar el dolor y la inflamación aguda.

- **AINEs y Paracetamol:** Se utilizan para el control sintomático del dolor y la rigidez.
- **Corticoides:** Se usan a dosis bajas como "terapia puente" o en pulsos durante crisis.
- - **Dato clave:** A diferencia de lo que se creía antiguamente, los corticoides también tienen cierta capacidad de modificar la progresión de la enfermedad, aunque **no reemplazan** a los FARME.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Nunca se debe mantener a un paciente con AR únicamente con corticoides o AINEs. El retraso en el inicio de un FARME (Metotrexato) se traduce en daño articular irreversible (erosiones) en pocos meses.

Consideraciones Especiales

Artritis Reumatoide y Embarazo

El manejo en el embarazo es complejo y debe ser liderado por un especialista: - **Metotrexato:** Está estrictamente **contraindicado** por ser teratogénico. Debe suspenderse meses antes de la concepción. - **Leflunomida:** También es altamente teratogénica. - **Alternativas:** Generalmente se prefiere el uso de **Sulfasalazina** o ciertos fármacos biológicos que no atraviesan la placenta en etapas críticas.

EUNACOM CRITERIOS

Ante una paciente con AR que desea embarazarse, la conducta inmediata es suspender el Metotrexato y derivar a reumatología para ajuste de terapia.

Contexto Nacional (Chile)

Es fundamental recordar que en Chile la **Artritis Reumatoide** es una patología **GES (AUGE)**. Esto garantiza: 1. Acceso a diagnóstico. 2. Tratamiento con FARME de primera y segunda línea. 3. Seguimiento por especialista. 4. Protección financiera (Copago máximo del 20%).

Para los casos refractarios, la **Ley Ricarte Soto** financia los fármacos biológicos (como el Etanercept o Adalimumab), previa evaluación por un comité de expertos.

Perlas para el EUNACOM

- **¿Cuándo empezar el tratamiento?** Tan pronto se haga el diagnóstico ("ventana de oportunidad").
- **¿Cuál es el fármaco inicial?** Metotrexato.
- **¿Qué controlar con MTX?** Pruebas hepáticas y hemograma (por riesgo de mielosupresión y hepatotoxicidad).

- **¿Qué hacer si el paciente tiene síntomas pero el MTX aún no actúa?**
Usar AINEs o corticoides a dosis bajas como puente.
- **¿Cuál es la terapia de rescate en Chile?** Biológicos vía Ley Ricarte Soto.

Si quieres profundizar en cómo identificar a estos pacientes, revisa el artículo sobre **Artritis Reumatoide: Diagnóstico**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"¿Cuál es el tratamiento de primera línea de la artritis reumatoide?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Artritis Reumatoide: Tratamiento. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El tratamiento base de la AR son los DMARs, no los corticoides ni los AINEs
- Metotrexato es la primera línea: dosis semanal, modifica radicalmente la evolución de la enfermedad
- Escalamiento: metotrexato → otro DMAR → combinación 2-3 DMARs → biológicos (anti-TNF-alfa)
- Biológicos principales: etanercept, adalimumab, infliximab
- Metotrexato está contraindicado en embarazo; se usan biológicos en su lugar
- AR es patología AUGE en Chile; biológicos en Ley Ricarte Soto
- El tratamiento sintomático (paracetamol, AINEs, corticoides) complementa pero no reemplaza los DMARs

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ARTRITIS REUMATOIDE: TRATAMIENTO)

PREGUNTA 1

¿Cuál es el tratamiento de primera línea de la artritis reumatoide?

- A) Prednisona oral
- B) Metotrexato semanal
- C) Etanercept
- D) Ibuprofeno
- E) Hidroxicloroquina

PREGUNTA 2

Paciente embarazada con artritis reumatoide activa. ¿Cuál es el manejo más apropiado?

- A) Metotrexato en dosis bajas
- B) Leflunomida
- C) Fármacos biológicos
- D) Ciclofosfamida
- E) Azatioprina en dosis altas

PREGUNTA 3

Paciente con AR que no responde a metotrexato en monoterapia ni a combinación con sulfasalazina e hidroxicloroquina. ¿Cuál es el siguiente paso?

- A) Aumentar dosis de metotrexato indefinidamente
- B) Terapia biológica con anti-TNF-alfa
- C) Solo corticoides en dosis altas
- D) Cirugía de reemplazo articular
- E) Suspender todo tratamiento

RESUMEN: ARTRITIS REUMATOIDE: TRATAMIENTO

El tratamiento de la artritis reumatoide se basa en las drogas modificadoras de la artritis reumatoide (DMARs). La primera línea es metotrexato en dosis semanal, que modifica radicalmente la evolución de la enfermedad. Si no es suficiente, se agrega o cambia a un segundo DMAR, luego combinaciones de 2-3 fármacos, y de última línea la terapia biológica (anti-TNF-alfa). Los DMARs incluyen metotrexato, azatioprina, micofenolato, leflunomida, sulfasalazina e hidroxicloroquina. Los biológicos más importantes son etanercept, adalimumab e infliximab. En Chile, la AR es patología AUGE y los biológicos están en la Ley Ricarte Soto. En el embarazo el metotrexato está contraindicado, se maneja con fármacos biológicos. El tratamiento sintomático (paracetamol, AINEs, corticoides) complementa pero no reemplaza a los DMARs. Los corticoides no solo son sintomáticos sino que modifican la enfermedad, pero lo más importante son los DMARs.